住院每日查房记录

姓名 / 代号_____ 第二标识_____ 日期 / 时间_____

床号_____ 住院第_____天 科室 / 记录医生_____

病情 稳定 / 病重 / 病危 复苏医嘱状态 / 核实情况_____

重要过敏及反应_____

注意事项 / 隔离要求_____ 原因_____

住院病程与近期变化

近期事件 / 患者关切；沟通对象、患者意愿与理解；分歧 / 待核实内容。

每日复核 血压_____ 心率_____ 呼吸_____ 体温_____ 血氧 / 氧疗方式与流量_____

意识状态_____ 输入 / 输出_____ 测量时间_____ 复评 / 监测安排_____

关键结果与趋势 来源 / 日期；危急结果注明通知、处理与复评

指标及单位	日期/时间_____	日期/时间_____	日期/时间_____

每日用药与管路 / 装置复核

当前用药：必要性 / 安全性 / 疗效；入院前用药核对。
抗菌药复评；管路 / 导管必要性；调整及依据。

重点查体与系统回顾

变化及关键阳性 / 阴性发现。
一般情况 / 心肺 / 腹部 / 皮肤 / 四肢 / 神经。

按问题列出的评估与计划

今日目标与优先级_____

评估：优先级 / 现状 / 可能病因；支持与反对证据；重要鉴别 / 不确定性。
计划：结果 / 会诊；检查 / 治疗；预期疗效 / 监测 / 复评；应变预案见下方。

每日安全与支持治疗复核

营养 / 吞咽；疼痛 / 睡眠；排便 / 排尿；
活动 / 康复；静脉血栓栓塞 / 出血；
跌倒 / 皮肤 / 谵妄。

出院计划

出院条件 / 去向 / 照护 / 资源可及性

用药与随访 / 患者理解

出院后未完成事项：负责人 / 联系 / 时限

待回报与待办 截至_____ 核对处理后勾选；未完成跨日保留

完成	待回报结果或待办事项	负责人 / 联系	时限及下一步
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			

应变预案与交接

问题 / 触发情况_____ 应对措施_____

负责 / 上级医师及联系_____ 复评时限_____ 照护限制_____

接收人 / 时间_____ 接收方确认 / 待跟进事项_____

参考框架：中国《医疗质量安全核心制度要点》（十八项核心制度）；美国 CMS 医院参与条件（CoPs）、Joint Commission 国家患者安全目标（NPSG；医院项目自 2026 年起由 NPG 取代）及 ACGME 住院医师培训通用要求（CPR）；英国 NICE CG50、NHS England / CPOC NatSSIPs；德国 G-BA QM-RL。
本模板参考上述框架中的相关原则，用于辅助初诊评估和住院患者管理，并支持临床思维与患者管理能力的培养和教学；不能替代医院 / 机构的正式病历、医嘱、管理系统或管理职责。

 © Junhui Liu M.D. 版权所有 反馈与支持：junhuiliu1025@gmail.com

住院患者背景与持续照护需求

本页保留使用，更新时注明日期；每日另用查房页，必要时增加关联续页。

姓名 / 代号_____ 第二标识_____ 日期 / 时间_____

入院日期_____ 科室 / 团队_____ 更新日期_____

相关既往病史

诊断 / 并发症；专科诊疗；
既往检查 / 治疗反应。

手术操作与重大医疗事件

手术 / 住院 / 急诊就诊；外伤；
装置 / 支持治疗；并发症。

入院前用药史

处方药 / 非处方药 / 补充剂；用药详情 / 实际使用 / 依从性；
信息来源 / 药房；用药差异。每日调整见第 1 页。

过敏史及反应

致敏物 / 反应 / 严重程度。
无已知过敏 / 不明 / 未评估。

社会与家庭背景

居住 / 支持 / 资源可及性；家族史；职业 / 暴露；
烟酒及其他物质使用；按需采集性与生育史。

基线功能与精神状态

日常活动 / 行动能力 / 辅具 / 跌倒；认知 / 情绪；
沟通能力 / 安全风险。

诊疗目标与决策

目标 / 决策能力 / 代理决策人；预立医疗指示。
当前复苏医嘱状态及治疗范围限制见查房页。

联系人与照护资源

照护者 / 基层医生 / 专科医生 / 药房；口译；
居家服务 / 设备 / 沟通偏好。

持续照护需求与资料

基线营养 / 吞咽 / 氧疗及其他支持；康复 / 居家服务 / 资源可及性；缺失资料。

背景信息更新（注明日期）

日期 / 来源 / 更新 / 已告知医生；患者或照护者核对事实、理解与更正意见。

参考框架：中国《医疗质量安全核心制度要点》（十八项核心制度）；美国 CMS 医院参与条件（CoPs）、Joint Commission 国家患者安全目标（NPSG；医院项目自 2026 年起由 NPG 取代）及 ACGME 住院医师培训通用要求（CPR）；英国 NICE CG50、NHS England / CPOC NatSSIPs；德国 G-BA QM-RL。
本模板参考上述框架中的相关原则，用于辅助初诊评估和住院患者管理，并支持临床思维与患者管理能力的培养和教学；不能替代医院 / 机构的正式病历、医嘱、管理系统或管理职责。

 © Junhui Liu M.D. 版权所有 反馈与支持：junhuiliu1025@gmail.com